

IOFR001

ATA MEMORIAL CENTRE ADVANCED CENTRE FOR TREATMENT, RESEARCH & EDUCATION IN CANCER REGISTRATION DETAILS



15/07/2026

Category C GENERAL

Case No. 12F2026/005361

Patient Name

Mr. SHARDANAND SATYANARAYAN LAL DAS

Permanent Home Address

ROOM NO -03 BHAGYODOY D,WING
DAHAD ROAD, SOLSUMBA
UMBERGANE, SOLSUMBA,
UMBERGAON, VALSAD, GUJARAT
VALSAD SOLSUMBA VALSAD
GUJARAT
INDIA

Pin Code 396165

Mobile 7283874223



Scan QR code to see EMR Reports

Address for Correspondence

ROOM NO -03 BHAGYODOY
D,WING DAHAD ROAD, SOLSUMBA
UMBERGANE, SOLSUMBA,
UMBERGAON, VALSAD, GUJARAT
VALSAD VALSAD SOLSUMBA
GUJARAT
INDIA

Pin Code 396165

Mobile 7283874223

Patient's Name
Relationship

ANJU DAS
WIFE

Mobile 9157316739

Patient's Address

ROOM NO -03 BHAGYODOY D,WING
DAHAD ROAD, SOLSUMBA
UMBERGANE, SOLSUMBA,
UMBERGAON, VALSAD, GUJARAT
VALSAD SOLSUMBA VALSAD
GUJARAT
INDIA

Pin Code 396165

Referring Physician's Name ANJU DAS

Relationship with Patient : WIFE

Date of Birth 26/09/1970

Age At Registration 55 yrs 9

Sex Male

Occupation SERVICE

Marital Status MARRIED

Nationality INDIAN

Family Income Rs. 58,000

Aadhar card no. **** * 94

Resident of Mumbai (More Than One Year) No

Identification mark

A ID: 91-7218-2741-6075

ABHA AD: 91721827416075@abdm

Referred By

Address

Referred For DMG - URO ONCOLOGY

Referred For TREATMENT

15/07/2026

10:01:46AM

10.100.27.51



सामान्य सहमतिपत्र

रोगी का नाम	Sharclanand Janyanarayana Lal Das	आयु/लिंग	55 / M
केस फाइल नंबर:	12F2026/005361	तारीख:	15/07/2026

गोपनीयता, स्वेच्छा एवं पूर्ण समझ के साथ निम्नलिखित बिंदुओं हेतु अपनी सहमति प्रदान करता/करती हूँ-

- मैं अपनी/मरीज की जाँच एवं उपचार हेतु व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ।
- मैं, अपनी/मरीज का उपयुक्त अस्पताल कर्मियों को शारीरिक परीक्षण/नैदानिक प्रक्रियाएँ करने की अनुमति देता/देती हूँ।
- मुझे एच.आई.वी. (HIV) परीक्षण के पूर्व आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया है, जिसके उपरान्त मैं स्वेच्छा एवं पूर्णतः सूचित समझ के साथ एच.आई.वी. परीक्षण कराए जाने हेतु अपनी विधिवत सहमति प्रदान करता/करती हूँ।
- मैं सहमत हूँ कि शैक्षणिक, अनुसंधान, स्वास्थ्य प्रशासन, कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मेरे मरीज की पहचान गोपनीय रखते हुए केस रिकॉर्ड के पूर्ण अथवा आंशिक भाग का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही, इन अभिलेखों को राष्ट्रीय कैंसर पंजी में भी सम्मिलित किया जा सकता है। मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि उपचार के दौरान मेरे मरीज की पहचान गोपनीय रखते हुए, मेरे मरीज के फोटोग्राफ अथवा वीडियो का उपयोग चिकित्सा प्रलेखन, शिक्षा अथवा अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मैं यह अधिकृत करता/करती हूँ कि मेरे मरीज की पहचान गोपनीय रखते हुए, मेरे/मरीज के रक्त अथवा ऊतक नमूनों को वर्तमान अथवा भविष्य के अनुसंधान प्रयोजनों हेतु एकत्रित कर संग्रहित किया जाए, तथा इन नमूनों की पहचान हटाकर गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उपचार के दौरान ली गई तस्वीरों/वीडियो का उपयोग चिकित्सा दस्तावेज़, शिक्षा अथवा अनुसंधान हेतु किया जा सकता है, बशर्ते पहचान गोपनीय रखी जाए।
- मैं यह स्वीकार करता/करती हूँ कि मरीज को गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में भर्ती करने अथवा वहाँ से छुट्टी देने का निर्णय पूर्णतः उपचाररत चिकित्सक और/या आईसीयू प्रभारी अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के विवेकाधिकार पर आधारित होगा।
- मैं यह भली-भाँति समझता/समझती हूँ कि किसी उच्च जोखिम वाले रोग की चिकित्सा अथवा चिकित्सा प्रक्रिया से जुड़े उपचार में प्रतिकूल प्रभाव, दुष्प्रभाव अथवा गंभीर चिकित्सकीय जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जो कभी-कभी घातक या गम्भीर रूप से हानिकारक भी हो सकती हैं। ऐसी किसी भी संभावना से मुझे पूर्व में अवगत कराया गया है तथा मैंने उसे समझने के पश्चात ही यह सहमति दी है।
- मुझे यह अवगत कराया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आवश्यक औषधियाँ अस्पताल की औषधि दुकान में उपलब्ध न होने पर बाहरी स्रोतों से खरीदी जा सकती हैं।
- मैं सलाह हेतु टेली-कंसल्टेशन अथवा अनुवर्ती परामर्श हेतु टेलीमेडिसिन सेवाओं के प्रयोग की अनुमति देता/देती हूँ।
- मैं सहमत हूँ कि अस्पताल आवश्यकता अनुसार मुझे/मरीज को टी.एम.सी. की अन्य इकाइयों में स्थानांतरित कर सकता है अथवा मैं/मरीज स्वयं ऐसा अनुरोध कर सकता/सकती हूँ।

10. अस्पताल सेवाओं से संबंधित सूचनाएं मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. व्हाट्सएप द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।

11. मुझे मेरी चिकित्सा स्थिति, उपचार विकल्प एवं जीवनशैली में अपेक्षित परिवर्तनों से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक जानकारी प्रदान की जा सकती है।

12. मैं अस्पताल द्वारा मरीज देखभाल हेतु पूर्व में निष्क्रमित एवं पुनः उपयोग योग्य कीटाणु-मुक्त उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देता/ देती हूँ।

13. मैं प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण के दौरान मरीज का अवलोकन एवं परीक्षण करने की अनुमति देता/देती हूँ।

14. मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे/मेरी मरीज के अधिकारों और जिम्मेदारियों को मुझे पूर्ण रूप से समझाया गया है, और मैं अपनी देखभाल के हिस्से के रूप में उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि संबंधित दावों के निपटान की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए अस्पताल को मेरे उपचार और चिकित्सीय अभिलेखों की जानकारी मेरे स्वास्थ्य बीमा प्रदाता के साथ साझा करनी पड़ सकती है।

15. मैं Anju Das (नाम), जो मेरे wife (रिश्ते का नाम) हूँ, को यह अधिकार देता/ देती हूँ कि यदि मैं उपचार के दौरान चिकित्सकीय रूप से अक्षम हो जाऊँ या निर्णय लेने में असमर्थ हो जाऊँ, तो वे मेरी ओर से निर्णय ले सकें। यदि मरीज नाबालिग, असहाय या स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ है, तो उपरोक्त नामित व्यक्ति उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

16. अस्पताल द्वारा दी जाने वाली सेवाओं एवं शुल्क निर्धारण से संबंधित सभी निर्णयों में मेरी सहमति है।

17. मुझे यह समझ में है कि यदि आवश्यक सुविधाएँ, सेवाएँ या बिस्तर उपलब्ध नहीं हों, या यदि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक समझा जाए, तो मुझे/मेरे रोगी को परामर्श अधवा आगे के उपचार/प्रबंधन के लिए अस्पताल के बाहर किसी अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थान में संदर्भित (रेफर) किया जा सकता है।

मैं उपर्युक्त सभी बिंदुओं को अपनी समझ में आने वाली भाषा में पूरी तरह समझकर, स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के यह सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

रोगी का नाम: Shardanand Suryanarayan Lal Das

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान:  तारीख: 15/07/2026 समय: 10.00 AM

रोगी सहमति देने में सक्षम नहीं है

कारण: ☐ नाबालिग ☐ बेहोश ☐ अन्य: _____

कानूनी संरक्षक/रिश्तेदार का नाम: _____

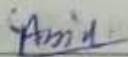
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान: _____

तारीख: _____

समय: _____

संबंध: _____

साक्षीदार (नाम): Anju Das

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान: 

तारीख: 15/07/2026 समय: 10.00 AM

स्वागत कक्ष कर्मचारी का नाम: Meena. V. Bhargava सी. सी. क्र. 124397

स्वागत कक्ष कर्मचारी का हस्ताक्षर: 

तारीख: 15/07/2026 समय: 10.00 AM

12

CASE NO.

12F2026/00536/

DATE / TIME	CLINICAL NOTES AND MANAGEMENT PLAN (For Clinician's Use only)	FOCUS NOTES (For Nurse's Use only)
Date: 15/7/26		Time: 9:19
Name: Shandana Das		Gender: M/F/O
Age: 56		
DMIC: A. Uno		
Modality: Surgical/Medical/ Radiation/ Nuclear Medicine/		
Category: General / Private		
Online registration number: 2026 071546319A		
Yojana: Y/N		AB/MJ
Credit: ESIC/ CGHS/CHHS/Railway/NA		
Navigator: Ankita	Sign: A	
Ce number: 128026		

TCC - Ref. → 303

Kajal (Newest)

15/07/26

@ 10:40am

PIR - 84m

MBP 130/80mmHg

15/07/26 D/w Dr. Vallish Su.

1) CBC, RFT, LFT, SE, Blood group.

HTV, HCU, HbA1c

A1-C
weak

SpO2 - 96%

Wt -

KLUO - HTN

Allergy - NO

2) vit B12, Folic acid, Iron, Ferritin, TIBC

3) 2D Echo, ECG

R29
(7)A1-C
✓

4) ACTH, Serum cortisol, T3, T4, TSH Urine R/M.

5) FAPI PET CT -

R24
weak

weakness of L.R.

CLINICAL NOTES AND MANAGEMENT PLAN

CASE NO.

001 - MSP

DATE / TIME	CLINICAL NOTES AND MANAGEMENT PLAN (For Clinician's Use only)	FOCUS NOTE (For Nurse's Use)
	6) USG guided biopsy.	Kindly mention indication for physician ref.
	7) Physician opinion.	9:30 am to 10:30 am
	8) R/w 22/07/26.	16/7/26. 10:30 am
07/07/26	2D ECHO Appointment Date: 22/07/2026 07/07/26 Time: 10:30 AM. Note: Bring old ECG/2D ECHO reports on the day of appointment. No Fasting Required.	As per patient requested to give apt on 29/07/26.
16/7/26	BP = 121/75 P = 89 SPo ₂ = 98.1% 16/07/26	
	Physician opinion for → anticoagulation med. e. Cardiac medication &? Pre diabetic	
16/07/2026	S/B (SR ↓ MED 10:40 AM (D's Ravi) c/D/W Ds - ASHWINI MAAM. 56/M, c/o RCC Right Kidney Cung - mets.	
	Referred i/v/o Comorbidities.	
	k/c/o HTN, PTCA (2022) CVA (2011, 2020)	(P-T-O)

DATE / TIME

CLINICAL NOTES AND MANAGEMENT PLAN
(For Clinician's Use only)FOCUS NOTES
(For Nurse's Use only)

(Contd)

left leg - polio
s/p Cholecystectomy.

TFT - (N)

Iron Profile s/o A.O.C.D

MCAC 32-6 (N)

egfr 104

Na 130

HbA1c =

Creat 0.79

K 4.68

5.9

LFT - (N)

↓
outside
report.

Prot (N)

Hb = 9.9.

TLC = 9.74

PLTC = 358.

Currently on

T. ATORVASTATIN 40mg
0-0-1

T. ASPIRIN 75mg (0-1-0)

T. BISOPROLOL 5mg (1-0-0)

T. LOSARTAN + HYDROCHLORTHIAZIDE
(50/12.5) 11-0-0

T. PRASUGREL 10mg (1-0-0)

T. TAMUSLOSIN 0.4mg (0-0-1)

2022 { PTCA to LAD and RCA
with 2 DES

CVA - No old records.

2011 - ? Numbness and
weakness of (P.T.O)

CASE NO.

12F 2026 / 5361

2D ECHO Appointment

Date: _____ Time: _____

Note: To bring old EGG/2D ECHO reports on the day of appointment.

FOCUS NOTES DATE / TIME

(For Nurse's Use only)

DATE / TIME

CLINICAL NOTES AND MANAGEMENT PLAN
(For Clinician's Use only)

Right lower limb. post Cholecystectomy

resolved by 1 week post discharge
No antiplatelet / or blood thinner
advised on discharge.

2022 - slip and fall

no head injury or paralysis.

2023: 1 to 2 episode Syncope - no hospitalisation

Now ~~on~~ On Cardiologist advice, is
still on dual antiplatelets. Since
2022.

Now, planned for biopsy

? Kidney upper mid pole.

May
July 2025)Old
outside
Echo:WEF
55%
RWMA

Adv:

ECG, 2D Echo (Date) → RRS
FBS, PPBS. Ground
floor.To STOP T-PRASUGREL 7 days prior to
planned surgery biopsy.To STOP T-ASPIRIN 75mg 3 days prior
to planned biopsy.Plan to restart antiplatelets once
adequate Hemostasis is ensured
post procedure.

(p-T.O)

CASE NO.

12F206/5361

DATE / TIME

CLINICAL NOTES AND MANAGEMENT PLAN
(For Clinician's Use only)FOCUS NOTES
(For Nurse's Use only)

(Contd)

Plan to restart on T- CLOPIDOGREL
instead of T- PRASUGREL. post proc

Follow up with ECG, Echo, FBS
PPBS reports as advised.

To bring old records on
next visit.

Dr. Ravi
SR. MED.

718120

CRF-

BP - 145/85

P - 73b/m

T - 98.1°

SpO₂ - 100%

R/C/L - HTH

CASE NO.

12f26/5361

/ TIME

CLINICAL NOTES AND MANAGEMENT PLAN
(For Clinician's Use only)FOCUS NOTES
(For Nurse's Use only)

7/3/21 Comorb → HTN / Old CVD / AIT+PTCA / Aspergillus - 2nd to Aspergillus

Imp - CC RCC - ISUP grade II

(Oligometastatic) - Long met

V/M → Neg

→ IMC → (2)

AUM / Costover / Bm → (N)

intermediate
size

2014HD → EF - 55% NO RWMA

Urine - R/M - 17 PR

Bm - 28 / TBC - 325

wt -

HL -

(3)

Alu

→ 2g Sincorb 1 gm in 250ml NS over 45 min

→ Hon for Tazopeloneb + Axitinib

→ < 1% risk of unexpected SK exacerbation
~~though~~ despite of comparative safety
profile of this regime

149cm

87kg



TATA MEMORIAL CENTRE

Advanced Centre for
Treatment, Research and
Education in Cancer
(ACTREC)

Doc. ID:
ACTREC/PRE/CONSENT/QF/016

Version:01

Version date:01.01.2026

INFORMED CONSENT -CHEMOTHERAPY / IMMUNOTHERAPY / TARGETED THERAPY / COMBINATION THERAPY

PATIENT NAME:	Shardanand Satyanarayan	AGE/ SEX:	56y/M.
CASE FILE No.:	12F2026/5361.	DATE:	

The doctor has explained that I have the following medical condition: Renal Cell Carcinoma
and I have been explained and advised to undergo the following treatment/procedure/chemotherapy:

Palliative.

The drugs used during the treatment are:

Laripalimab + Axitinib.

Introduction

Chemotherapy/ Immunotherapy/Targeted therapy or a combination of any of the above is a treatment given to cancer patients. During this process, anti-cancer drugs are administered to a patient.

Technique

Cancer treatments can be administered using different techniques depending on the type of therapy. **Chemotherapy** is usually given through an intravenous (IV) line or a central line for long-term treatment, though some drugs can be taken orally as tablets. **Immunotherapy** is commonly administered via IV infusion, subcutaneous injection, or adoptive cell therapy, where modified immune cells are re-infused into the patient. **Targeted therapy** is mainly given orally, but some drugs are given IV, depending on specific genetic or molecular markers. **Combination therapy** uses two or more therapies together, with each administered via its standard route, carefully scheduled to maximize effectiveness and minimize side effects.

Intended Benefits (To be documented by doctor)

- To give you the best possible chance of being cured.
- To control or shrink the tumour.
- To improve the quality of life and survival.
- Others, if any specify:

Alternatives (To be documented by doctor)

Risks and Complications (To be documented by doctor)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Visual changes Blurred vision, itching, tearing Weight loss Weight gain Temporary hair loss Skin rash Acne Fatigue IV site discomfort Darkening of skin/nails Facial flushing Appetite change Urine discoloration Menstrual irregularities Hot flashes | <ul style="list-style-type: none"> Chills Fever Nausea Vomiting Diarrhoea Constipation Depression Mouth sores Skin/Eye light sensitivity Allergic reactions Bladder irritation Hearing loss Skin ulceration/Skin rashes Numbness/tingling Sterility/Fertility Hypertension |
|--|--|

Patient Specific Risks (To be documented by doctor)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Risks and Outcome of No Treatment (To be documented by doctor)

- Disease progression
- Worsening of symptoms
- Deterioration of quality of life
- Organ dysfunction/Failure
- Death
- All of the above
- Others, if any specify:

TATA MEMORIAL CENTRE
ACTREC
Department of Medical Oncology

Treatment Protocol

Case No : 12F2026/005361 Name : Mr. SHARDANAND SATYANARAYAN LAL DAS Age : 56 Sex : Male

Joint Clinic No : 1 Plan No : 1 No of Cycles : 12

Height : 149 Cms Weight : 87 Kgs BSA : 1.90 m²

Protocol Name : GU-TORIPALIMAB+AXITINIB Date of Protocol : August 07, 2026

Diagnosis : KIDNEY NOS --Renal Cell Intent: Palliative

Carcinoma

Note: - D: is Day of the Cycle * Indicates Drug is administered/given at TMC X Indicates Item is not schedule for that Cycle

Drug Name	Drug Description	Cycle 1 [21 Days]	Cycle 2 [21 Days]	Cycle 3 [21 Days]	Cycle 4 [21 Days]
TORIPALIMAB	240.00 mg, 240.00 mg(Total Dose), Intravenous Peripheral Line, in 250 ml Once of Normal Saline, over 1 Hours as Infusion, Use an 0.22 micron in-line filter	D:1 <i>240mg</i>	D:1	D:1	D:1
AXITINIB	5.00 mg, 5.00 mg(Total Dose), Per Oral Two Times, same time of day, irrespective of food	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, <i>25mg</i> D:14, D:15, <i>5mg</i> D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21
		Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:

pl
139982

↑
reassess

Joint Clinic No : 1

Plan No : 1

No of Cycles : 12

Height : 149 Cms

Weight : 87 Kgs

BSA : 1.90 m²

Protocol Name : GU-TORIPALIMAB+AXITINIB

Date of Protocol : August 07, 2026

Drug Name	Drug Description	Cycle 5 [21 Days]	Cycle 6 [21 Days]	Cycle 7 [21 Days]	Cycle 8 [21 Days]
TORIPALIMAB	240.00 mg, 240.00 mg(Total Dose), Intravenous Peripheral Line, in 250 ml Once of Normal Saline, over 1 Hours as Infusion, Use an 0.22 micron in-line filter	D:1	D:1	D:1	D:1
AXITINIB	5.00 mg, 5.00 mg(Total Dose), Per Oral Two Times, same time of day; irrespective of food	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21
		Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:

Drug Name	Drug Description	Cycle 9 [21 Days]	Cycle 10 [21 Days]	Cycle 11 [21 Days]	Cycle 12 [21 Days]
TORIPALIMAB	240.00 mg, 240.00 mg(Total Dose), Intravenous Peripheral Line, in 250 ml Once of Normal Saline, over 1 Hours as Infusion, Use an 0.22 micron in-line filter	D:1	D:1	D:1	D:1
AXITINIB	5.00 mg, 5.00 mg(Total Dose), Per Oral Two Times, same time of day; irrespective of food	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21	D:1, D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:8, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:15, D:16, D:17, D:18, D:19, D:20, D:21
		Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:	Nursing. sign: Dr. sign:

Consultants signature: _____